

<성과확산형> 연차별(2차년도) 사업계획서

1. 사업명 : 취약계층 아동 심리지원 동행자 연계 사업

2. 사업 내용 및 추진 전략

1) 사업 참여자 모집 전략

(1) 참여 대상 및 인원

핵심 참여자	- 지역 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 (8세~16세) 50명 ※ 재활·동행 지원 35명, 동행연계 15명 ※ 취약계층 기준 - 중위소득 120% 이하 가정 - 동행자 4명 ※ 중위소득 120% 초과~150% 이하 가정의 경우 사례회의를 통해 후순위로 대상자 선정
주변 참여자	- 보호자 및 대리양육자(지역아동센터 생활복지사 등) - 재활전문가(의사, 상담가, 치료사 등) - 유관기관 담당자

(2) 참여자 선정 기준

복구 및 동구	- 지역 내 지역아동센터, 유관기관으로부터 추천받은 아동 중 사전검사(K-CBCL, TRF)를 통해 심리·정서적으로 임상범위에 준하는 아동 - 1순위: 임상범위에 속하며, 재활·동행 지원이 필요한 아동(40%) - 2순위: 동행연계가 필요한 아동(30%) - 3순위: 준임상범위에 속하며 재활·동행 지원이 필요한 아동(30%) ※ 유관기관: 지역아동센터, 드림스타트, 교육지원청, 재활센터 등 ※ 임상범위기준: 사전검사 총합 130점 이상, 준임상범위 기준: 사전검사 총합 110점~129점
---------------	---

(3) 참여자 모집 방안

구분	복구	동구
대상자모집	- 재활·동행 지원이 필요하다고 보이는 아동(지역아동센터 및 유관기관) - 재활·동행 지원이 필요하다고 보이는 아동(복지관 사례관리사업팀 내 위기아동 등) - 외부기관을 통해 재활비 지원이 가능하나 동행자 연계가 필요한 아동	- 재활·동행 지원이 필요한 아동 70%, 동행연계만 필요한 아동 30%
회의 및 선정	- 사전검사(K-CBCL, TRF) 토대로 대상자 선정	

2) 연차별 사업내용

1차년도	
특징	- 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 사업 구축 - 아동 맞춤형 심리치료 진행 및 동행자 연계 체계 구축 <u>재활·동행 지원이 필요한 아동 90% / 동행연계가 필요한 아동 10%</u>
핵심 내용	- 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 심리·정서 지원 ▶ '아이' 만나기 - 사업안내 및 스크리닝 ▶ '동행자' 만나기 - 동행자 및 맞춤재활 연계 - 동행자 간담회 및 교육 진행 ▶ '주변' 만나기 - 참여기관 간 네트워크를 통한 아동상황 공유 - 아동변화를 위한 보호자 상담 참여(재활사를 통한 비대면 보호자 상담) - 전문가 슈퍼비전
2차년도	
1차년도 대비 변경사항	· 대상자 선정 기준 완화 및 비율 조정 - 중위소득 120% 초과~150% 이하 가정의 경우 사례회의를 통해 후순위 대상자 선정 - 재활·동행 지원이 필요한 아동 70% / 동행연계가 필요한 아동 30% · 보호자 참여 확대 - 기존 월 1회 재활사를 통한 비대면 상담→욕구에 의한 대면 상담 추가 지원 · 동행자 역량강화교육 확대 - 아동 특성별 교육 등 동행자 역량을 강화하기 위한 교육을 1차년도 2회에서 5회로 확대
특징	- 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 사업 안정화 및 동행자 연계 활성화 - 동행자 역할 강화 및 연계 체계화 - 대상자 아동지지체계 참여 확대 <u>재활·동행 지원이 필요한 아동 70% / 동행연계가 필요한 아동 30%</u>
핵심 내용	- 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 심리·정서 지원 ▶ '아이' 만나기 - 사업안내 및 스크리닝 ▶ '동행자' 만나기 - 동행자 및 맞춤재활 연계 - <u>동행자 역량강화교육 및 간담회 활성화</u> ▶ '주변' 만나기 - 참여기관 간 네트워크를 통한 아동상황 공유 - <u>아동변화를 위한 보호자 상담 참여 확대(재활사를 통한 비대면, 대면 보호자 상담 지원)</u> - 아동 재활 진행상황에 대한 피드백 제공 - 전문가 슈퍼비전

3차년도

특징	- 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 동행자 연계 사업 체계의 모델화 - 동행자 연계 사업 종료 후 지속가능성을 위한 지원사항 논의 - 재활·동행 지원이 필요한 아동 46% / 동행연계가 필요한 아동 54% - 동행자 인력 증가(4명→6명)
핵심 내용	- 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 심리·정서 지원 ▶ '아이' 만나기 - 사업안내 및 스크리닝 ▶ '동행자' 만나기 - 동행자 및 맞춤형재활 연계 - 전문성 강화를 위한 동행자 교육 및 간담회 활성화 ▶ '주변' 만나기 - 참여기관 간 네트워크를 통한 아동상황 공유(3개년 사업 성과공유회 개최) - 아동변화를 위한 보호자 및 대리양육자 상담 참여(재활사를 통한 대면 상담) - 보호자 양육코칭을 위한 부모교육 진행 - 아동 재활 진행상황에 대한 피드백 제공 - 전문가 슈퍼비전 - 동행자 시스템 구축, 체계화를 위한 외부기관 네트워크 진행

3) 기관 연계협력 전략

협력기관명	세부 사업명	협력 계획	비고
지역아동센터 연합회 (총 19개소)	사업안내	- 사업협조를 위한 사전 사업 홍보 및 안내 - 보호자 참여 유도를 위한 상담 진행 - 심리·정서 지원이 필요한 대상자 발굴 및 추천 - 아동에 대한 사전·사후 검사(K-CBCL, TRF) 협조	기관
	유관기관 네트워크	- 아동에 대한 상호 간 피드백 공유 - 아동 재활 상황 및 재활센터 피드백 보호자 공유 - 보호자 사업 만족도 조사 진행 협조	
지역사회 유관기관	사업안내	- 심리·정서 지원이 필요한 대상자 추천	
	유관기관 네트워크	- 아동에 대한 상호 간 피드백 공유	
전문병원	종합심리검사 (full-battery 검사)	- 사전검사를 통해 선정된 아동에 대한 종합심리검사 (full-battery 검사) 진행	
재활센터	사업안내	- 심리·정서 지원이 필요한 대상자 추천	
	종합심리검사 (full-battery 검사)	- 사전검사를 통해 선정된 아동에 대한 종합심리검사 (full-battery 검사) 진행	
	유관기관 네트워크	- 재활개입 계획 수립, 아동 개입방안에 대한 피드백 - 참여아동에 대한 정확한 이해와 지도방법 안내	
	보호자 참여	- 참여아동에 대한 정확한 이해와 지도방법 안내	
아동 분야 전문기관 및 지역대학	사업운영	- 전문가 슈퍼비전	

3. 예산 편성

(단위 : 천원)

구분		1차년도			2차년도			3차년도		
목	세목	신청금액	자부담		세목	신청금액	자부담	세목	신청금액	자부담
	총 계	100,000,000	1,800,000		총 계	100,000,000	1,200,000	총 계	100,000,000	1,800,000
직접비	'아이' 만나기	스크리닝 (K-CBCL검사)	480,000	-	사업홍보	2,000,000	-	사업홍보	700,000	-
					사전검사 (K-CBCL, TRF)	300,000	-	사전검사 (K-CBCL, TRF)	270,000	-
		종합심리 검사	3,532,000	-	종합심리 검사	2,760,000	-	종합심리 검사	2,300,000	-
	동행자 만나기	동행자 활동비	32,748,000	-	동행자 활동비	34,150,000	-	동행자 활동비	37,950,000	-
		동행자 간담회	210,000	-	동행자 간담회	180,000	-	동행자 간담회	225,000	-
		동행자 교육	400,000	-	동행자 교육	1,000,000	-	동행자 교육	1,800,000	-
		맞춤치료	51,000,000	-	맞춤치료	47,025,000	-	맞춤치료	35,475,000	-
		사후검사 (K-CBCL검사)	270,000	-	사후검사 (K-CBCL, TRF)	210,000	-	사후검사 (K-CBCL, TRF)	180,000	-
	'주변' 만나기				보호자 참여	1,100,000	-	보호자 참여	2,850,000	-
		유관기관 네트워크	1,310,000	-				대리양육 참여	1,100,000	-
					유관기관 참여	1,350,000	-	유관기관 참여	2,150,000	-
		슈퍼비전	100,000	-	슈퍼비전	100,000	-	슈퍼비전	300,000	-
	소 계	90,050,000	-		소 계	90,175,000	-	소 계	85,300,000	-
간접비용	차량비	9,600,000	1,200,000		차량비	9,600,000	-	차량비	14,400,000	-
	출장여비	-	600,000		출장여비	-	1,200,000	출장여비	-	1,800,000
	사무용품	350,000	-		기타용품	225,000	-	기타용품	300,000	-
	소 계	9,950,000	1,800,000		소 계	9,825,000	1,200,000	소 계	14,700,000	1,800,000

4. 문제 의식(사업 필요성)

1) 사업 계획 배경

가. 대상자의 욕구 및 문제점

(1) 아동·청소년 정신건강 문제의 현주소

2024년 보건복지부와 질병관리청이 발표한 2022년 소아·청소년 정신건강 실태조사¹⁾에 따르면, 우리나라 아동·청소년의 정신건강 문제가 심각한 수준에 이르고 있음을 알 수 있다. 조사에 따르면, 6세에서 17세 사이의 아동·청소년 중 약 16.1%가 우울증, 불안 장애, ADHD(주의력 결핍 과잉행동장애) 등의 정신건강 장애를 경험한 것으로 나타났다. 이 중 7.1%는 현재 정신건강 문제가 지속되고 있어 전문적인 치료와 관리가 필요한 상황이다. 특히, 청소년에서는 이러한 비율이 더욱 높는데, 13세 이상의 청소년에서는 9.5%가 정신건강 문제를 겪고 있다고 보고되었다.

그럼에도 불구하고, 정신건강 문제를 겪고 있는 아동·청소년들이 적절한 치료를 받지 못하는 경우가 많은 것을 확인할 수 있다. 조사에 따르면, 정신건강 서비스를 이용한 아동·청소년은 4.3%에 불과하였으며, 이는 전체 정신장애를 겪는 아동·청소년 중 극히 일부에 해당한다. 이러한 저조한 서비스 이용률은 아동·청소년들이 정신건강 치료를 받기 위한 실질적인 장벽이 많다는 점을 강조한다. 서비스의 부족뿐만 아니라, 부모의 정신건강에 대한 인식 부족, 비용 문제, 치료의 필요성을 인식하지 못하는 경우가 많기 때문이다.

(2) 재활연계로 이어지지 못하는 원인 해소

앞선 내용과 같이 정신건강 서비스를 이용함에 있어 보호자의 상황과 인식 등을 실질적인 장벽 중 하나로 볼 수 있다. 다음은 드림스타트 아동통합사례관리사를 통해 확인한 보호자의 상황으로 인한 재활의 어려움을 볼 수 있는 실사례이다.

재활비 지원뿐만 아니라 동행 서비스 필요

드림스타트 아동통합사례관리사

아동은 친부모가 이혼하여 현재 친모와 함께 거주하고 있는 상황이다. 친모는 지속적인 가정폭력으로 인한 심한 우울감으로 극단적인 선택을 한 적이 있는 것으로 확인되었다. 이러한 환경에서 아동은 초등학교 1학년임에도 불구하고 심한 욕이나 막말을 하고 때를 쓰며 학교를 포함한 대인관계 형성에 어려움을 겪는 것으로 확인되었다. 이에 드림스타트에서는 아동의 치료가 시급하다고 판단되어 재활비를 지원했으나 친모의 우울감 등 가정환경으로 인해 아동의 동행이 어려운 상황이라고 한다.

위 사례를 통해, 유관기관을 통해 재활비를 지원받을 수 있음에도 불구하고, 보호자의 사정으로 동행이 불가하여 재활 진행이 되지 않는 경우가 빈번함을 알 수 있다.

또한, 보호자의 경우 본인의 자녀는 아무런 문제가 없다고 생각하거나, 무관심, 무기력 등으로 자녀를 제대로 돌보지 않는 경우가 있다. 이는, 아동의 재활이 필요하다라도 실질적인 연계까지 이루어지지 않는 문제를 야기한다. 해당 문제를 1차년도에는 기관이면서 대상자 발굴 및 추천 기관인 지역아동센터를 통해 보호자를 설득함으로써 해결할 수 있었다.

종합적으로 재활연계까지 이어지지 못하는 문제점을 해결하기 위해서는 재활비 지원뿐만 아니라 동행 서비스가 함께 진행되어야 함을 알 수 있다.

1) 박명숙, 2022년 소아·청소년 정신건강실태조사 보고서, 국립정신건강센터, 2024.

(3) 지역사회 유관기관 FGI(초점집단 인터뷰)를 통해 확인한 동행 연계 필요성

사업의 필요성, 효과성, 개선점 등에 대한 전문적인 근거자료를 도출하기 위해, 지역사회 유관기관 담당자를 대상으로 FGI(초점집단 인터뷰)를 진행하였다. 결과는 다음과 같다.

동행사업은 필수! 하지만, 대상자 확대 필요

교육지원청 교육복지사

과거와 달리 최근 교내에서 ADHD(주의력결핍과잉행동장애) 등의 영향으로 폭력성, 충동 행동을 보이는 학생이 교실에서 문제를 일으키는 경우가 잇따라 발생하고 있다. 아무리 문제가 심각한 학생이라 하더라도, 보호자가 상담·재활을 거부하면 더는 손쓰기 어렵다. 보호자가 여러 가지 사정으로 인해 협조가 되지 않으며, 대부분의 보호자가 직장에 다니고 있어 재활을 시작도 하지 못하는 경우가 다반사이다. 문제행동이 있는 아동의 경우 재활을 통해 충분히 개선될 수 있음에도 불구하고 보호자의 사정으로 인해 적절한 시기에 재활을 받지 못하는 현실이 안타깝다. 과거와 달리 보호자 모두 맞벌이를 하는 경우가 대부분이기 때문에 취약계층만이 아닌 아동을 양육 중인 전체 부모를 위해서 동행 서비스가 필요하다.

단순 동행만이 아닌 위기발굴, 정서적지지까지

드림스타트 아동통합사례관리사

친모가 암으로 사망하여 아동이 심한 우울감을 표출하고 있으나 계부의 정서지원도 제대로 이뤄지지 않고 있어 아동에 대한 재활이 시급했다. 계부에게 아동의 재활 필요성을 안내하며, 재활비 지원까지 약속했지만 계부의 사정(건강상 문제, 아동 동생 양육) 등의 문제로 아동의 재활을 계속해서 미루고 있었던 상황이었다. 최근 아동과의 상담을 통해, 아동이 적절한 재활 및 동행자로부터 정서적지지를 받으며 큰 도움을 받고 있다고 전해 들었다. 동행자가 단순 동행 지원만 하는 것이 아니라 아동의 정서적지지 등 다양한 역할을 하고 있어, 동행자 연계 사업이 아동의 건강한 성장을 도울 수 있는 사업이라고 생각한다.

위 인터뷰 내용을 통해, 심리·정서적으로 어려움을 겪고 있는 아동은 점차적으로 늘어나고 있으며, 재활비 지원이 아닌 실질적인 재활 연계를 위해 동행 서비스가 필요함을 알 수 있다. 종합적으로 인터뷰 내용을 비추보면, 동행 서비스에 대한 욕구, 필요성을 확인할 수 있었으며, 더 나아가 역량강화 교육을 통해 동행자의 역할이 단순 동행만이 아닌 아동의 정서적지지 등 다양한 역할을 수행할 필요가 있음을 알 수 있다.

나. 시 환경적 특성

(1) 시 지역적 특성

교육청에서는 아동을 대상으로 실태조사²⁾를 진행하였다. <표 1>은 실태조사 내 정서행동특성검사를 한 결과이다. “괜한 걱정을 미리한다”라는 불안척도를 묻는 문항에서 4점 만점에 2.59점, 2.56점으로 평균점수 이상을 보이고 있다. 또한 “나는 모든 것이 귀찮고 재미가 없다” 문항에서도 평균점수에 가까운 결과를 보인다. 다른 문항들도 앞서 문항에 비해 상대적으로 점수가 낮지만, “죽고 싶다는 생각이 든다”와 같은 문항에 체크한 아동이 있음을 보면 전반적으로 아동에 대한 관심이 필요한 시점이다.

2) 2022 교육복지실태조사, 교육청

<표 1> 정서행동특성검사

구분	평균(전체 4점)	동구	북구
나는 내 삶이 행복하다고 생각한다.	3.25	3.27	3.41
나는 모든 것이 귀찮고 재미가 없다.	1.68	1.67	1.66
죽고 싶다는 생각이 든다.	1.24	1.19	1.20
어른들이 이래라 저래라 하면 짜증이 난다.	2.24	2.13	2.21
괜한 걱정을 미리 한다.(불안)	2.54	2.56	2.59

다. 경험적 근거

(1) 치료개입사업에서 현재의 동행자 연계 사업으로의 변화

본 복지관에서는 [] 공동모금회 지원을 받아 [] 취약계층 아동의 정서·문제행동에 대한 치료개입사업 “아이(i)-ing”을 2019년~2022년까지 총 3년에 걸쳐 62명에 대한 아동에 대해 개입하였다. 해당 치료개입사업은 아동 치료뿐만 아닌 보호자 및 대리양육자 상담 참여, 코워크(기관 네트워크)를 통해 아동을 둘러싼 지지체계의 역할강화를 도모하였다. 이를 통해 전반적으로 아동의 변화에 큰 영향을 끼쳤다.

이후, 사업의 연속성, 사회적 문제에 의한 필요성, 지역사회 유관기관의 요청 등으로 본 복지관에서는 [] 사회복지공동모금회 지원을 받아 지역을 확대하여 취약계층 아동 심리지원 동행자 연계 사업 []을 []부터 현재까지 진행 중에 있다. 치료개입사업의 3년 간의 수행경험을 토대로 원활하게 수행하고 있으며, 현재까지 임상범위, 준임상범위, 동행 연계로 구분하여 총 55명에 대한 재활·동행 연계를 지원하고 있다. 또한, 아동에 대한 사전검사, 종합심리검사, 동행자 연계, 맞춤형 재활 연계, 보호자 및 대리양육자에게 정기적인 피드백 등 아동의 환경체계에 대한 접근을 통해 다양한 부분에서 성과를 나타내고 있다.

2) 기존 유사사업과의 차별성

지역 내 유관기관에서 수행하고 있는 심리·정서 지원사업의 경우, <표 2>를 통해 볼 수 있듯이 심리검사 혹은 재활비 지원이 이뤄지고 있으나 그 전체 회기가 평균 10회기에 그치고 있으며, 그마저도 동행 서비스를 제공하지 않아 직접 재활센터에 방문을 해야 한다. 재활센터의 재활 과정을 보면, 아동 재활 이후 보호자 상담이 이뤄지기 때문에 보호자 동행이 필요하다. 현대 사회에서는 보호자 모두 맞벌이를 하는 경우가 대부분이고, 특히 취약계층 가정은 아동의 재활을 위해 동행하는 것이 생계에도 큰 영향을 끼칠 수 있어 동행에 어려움이 상당하다.

<표 2> 울산 내 심리·정서 지원사업 현황

사업명	기관	사업내용	회기	역할	동행 서비스 여부	비고
찾아가는 청소년 동반자 사업	상담복지센터	찾아가는 상담 프로그램으로 도움이 필요한 청소년을 동반자가 직접 찾아가 상담서비스, 사례관리, 지역사회자원연계 서비스를 제공	3개월(10회기)	방문상담 및 자원연계/ 필요시 실행위원회 개최 및 지원	지원 있음	-
고위기 청소년 프로그램	상담복지센터	심리검사를 통해 고위기 청소년을 발굴하고 상담가가 파견하여 고위기 청소년에 대한 지지 및 서비스 제공	6개월	심리검사비 지원 및 청소년상담가 파견/ 부모상담 비용 지원	지원 없음	-
심리발달검사 및 심리치료사업		심리재활이 필요한 아동에 대해 심리검사·치료지원 서비스 제공	주 1회(6개월) (총 24회기) ※ 최대 1년	재활·검사비 지원	지원 없음	-
Wee센터	교육지원청	초·중학생 대상 심리재활 및 병원비 지원	심리검사 1회 치료비 10회기 (50만원 상당)	재활·검사비 지원	지원 없음	-
맞춤형 심리치료사업	안전망센터	초·중학생 대상 심리재활 및 병원비 지원	연 1회 (100만원) 학교신청 원칙 최대 10회 작업방문 및 센터연계	재활·검사비 지원	지원 없음	-

3) 신청기관의 강점

본 복지관에서는 <표 3>와 같이 공동모금회 지원으로 취약계층에 대한 심리·정서 지원사업을 수행한 경험이 있으며, 진행한 사업의 경우 업무 협약 12곳, 재활센터 9곳 연계, 유관기관 참여 18곳, 아동 117명을 지원함으로써 원활히 사업을 진행한 경험이 있다.

<표 3> 취약계층 심리·발달 지원사업 수행현황

연도	지원처	지원세대 수	비고
	사회복지 공동모금회	검사비 및 재활비 24명	-
	사회복지 공동모금회	검사비 및 재활비 19명	-
	사회복지 공동모금회	검사비 및 재활비 19명	-
	사회복지 공동모금회	재활 및 동행 연계 55명	-

아래 <표 4>는 본 복지관이 지역사회 유관기관과 연계되어 있어 대상자 모집, 필요한 자원연계, 슈퍼비전 등이 용이하다는 것을 나타낸다. **각 지역사회 유관기관의 경우 취약계층 및 돌봄-재활이 필요한 아동들이 많이 있고** 보호자의 역할이 아동 변화에 큰 영향을 주는 만큼 아동을 직접 관리하는 유관기관에서 보호자 참여를 이끌어내는데 용이하다. 그 외 고위험 아동의 경우 본 복지관 사례관리팀에서 협력네트워크를 정기적으로 수행하고 있어 다양한 기관과의 협력관계 마련을 통해 위기세대에 대한 자원연계, 슈퍼비전 등 협업하여 아동과 가족구성원의 개입이 가능하다. 이외에도 본 사업이 종료 후 참여아동이 타 지역(구)으로 거주지를 이전하더라도 각 복지관 사례관리팀으로 의뢰하여 사례관리 및 서비스에 대한 개입이 중단되지 않고 이어나갈 수 있는 강점이 있다.

<표 4> 지역사회 유관기관 네트워크 현황

기관명	네트워크 내용	비고
지역아동센터 연합회	· 지역아동센터 사업안내 및 대상자 의뢰	-
청소년상담복지센터	· 청소년복지실무위원회 · 고위기 청소년 사례공유 및 논의 · 아동-청소년 관련 지원사업 수행	-
협의체	· 교육복지 네트워크 · 교육지원청, 교육복지안전망센터, 복지관 사례관리 담당자, 교육복지사	-
민관협력 실무자 네트워크	· 복지사각지대 발굴을 위한 사회복지 유관기관 네트워크 · 노인, 장애, 지역, 아동 영역 민관기관 참여 · 일자리, 건강, 복지지원과 등 공공기관 참여	-
청 희망복지지원단, 동 행정복지센터	· 민관 협력 네트워크를 통한 사업 안내 및 담당자 간의 교류 · 연 2회 이상 네트워크를 수행하고 있으며, 찾아가는 네트워크로 각 동으로 방문하여 교류	-
동지역사회보장협의체	· 복지사각지대 발굴을 위한 협력사업 · 기타 지역에 필요한 공동사업 수행 · 동지역사회보장협의체에 복지관 직원이 1명씩 위원으로 배치	-
기타 민간기관	· 연 2회 이상 지역 내 있는 민간기관을 방문하여 사업공유 및 서비스 안내 ※ 사업 관련 필요하다고 판단되는 기관을 선정하여 방문	-
사회복지관협회 사례관리자 모임	· 참여아동 거주지 이전 시 필요에 따라 사례의뢰	

5. 목표 및 평가

1) 성과평가

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
지역 내 심리·정서 위기아동 발굴	- 성과지표 : 지역 내 심리·정서 위기아동 발굴 - 평가도구 : K-CBCL, TRF - 평가방법 : K-CBCL, TRF 검사를 통해 고위험 아동 건수 확인	사업 시행 후
참여아동의 심리·정서의 긍정적 변화 및 문제행동의 감소	- 평가도구 : 1) K-CBCL, TRF 2) 재활전문가 평가서 3) 동행자 아동관찰일지 또는 평가자료 4) 보호자·대리양육자를 통한 아동 변화 확인 - 평가방법 : 평가도구를 활용한 참여아동의 심리·정서적 상황의 전·후 비교	사업 시작, 종료 시
보호자 부재 아동에 대한 동행 연계 만족도 증가	- 성과지표 : 동행 연계 횟수 및 연계 만족도 - 평가방법 : 1) 실제 동행 연계 횟수 결과 2) 동행자, 보호자, 대리양육자 FGI	사업 시행 후
참여아동 보호자의 긍정적 양육태도 변화	- 평가도구 : 만족도 조사 - 평가방법 : 1) 만족도 조사 결과를 활용한 평가 2) 보호자, 대리양육자 FGI	사업 시작, 종료 시

6. 사업종료 후 지향점

1) 사업 수행으로 인한 기대 효과

- 지역사회 유관기관의 대상자 추천을 통해 심리·정서적 문제행동(고위험)을 보이는 아동에게 재활 및 동행자 연계 기회를 마련하여 건강한 정신건강 성장을 도모하고자 함.
- 사업 기간 내 아동뿐만 아니라 보호자 및 대리양육자 개입(참여)을 통해 가족기능강화를 도모하고 아동지지체계 역할의 중요성을 강조함으로써 아동에 대한 건강한 가족관계 유지가 가능하도록 함.
- 사업 효과성에 대한 내용을 지역사회 유관기관들과 공유함으로써 지역사회 내 동행 서비스에 대한 관심도를 증대시켜 관련 지원이 확대될 수 있도록 함.

2) 사업 결과의 활용 계획

- 사업결과를 토대로 향후 외부 공모사업 신청 시 이를 활용하고자 하며, 보호자와 대리양육자의 상담(교육)을 통해 아동이 올바르게 성장할 수 있도록 지지하고자 함.
- 지역사회 유관기관들과 사업 효과성 공유를 통한 동행 서비스에 대한 관심도를 높여 향후 유사사업 진행 및 확대에 활용하고자 함.

3) 사업 지속 유지 전략

- 각 연차별 정기 네트워크 진행, 3차년도 최종 성과공유회를 개최하여 사업의 필요성을 전달하고 아동에 대한 구체적인 지원사항이 논의될 수 있도록 노력하고자 함. 본 과정에서 사업결과가 표준화된 모델이 될 수 있도록 나아가고자 함.
- 동행자 발굴을 통해 동행 서비스 네트워크망을 구축하고자 하며 점진적으로 동행자 발굴 시스템이 확장 및 제도화되어 정착될 수 있도록 노력하고자 함.

<성과확산형> 연차별(2차년도) 사업계획서

1. 사업명 : 취약계층 아동 심리지원 동행자 연계 사업

2. 사업 내용 및 추진 전략

1) 사업 참여자 모집 전략

(1) 참여 대상 및 인원

핵심 참여자	- 지역 정서·문제 행동을 가진 취약계층 아동 (8세~16세) 50명 ※ 재활·동행 지원 35명, 동행연계 15명 ※ 취약계층 기준 - 중위소득 120% 이하 가정 - 동행자 4명 ※ 중위소득 120% 초과~150% 이하 가정의 경우 사례회의를 통해 후순위로 대상자 선정
주변 참여자	- 보호자 및 대리양육자(지역아동센터 생활복지사 등) - 재활전문가(의사, 상담가, 치료사 등) - 유관기관 담당자

(2) 참여자 선정 기준

북구 및 동구	- 지역 내 지역아동센터, 유관기관으로부터 추천받은 아동 중 사전검사(K-CBCL, TRF)를 통해 심리·정서적으로 임상범위에 준하는 아동 - 1순위: 임상범위에 속하며, 재활·동행 지원이 필요한 아동(40%) - 2순위: 동행연계가 필요한 아동(30%) - 3순위: 준임상범위에 속하며 재활·동행 지원이 필요한 아동(30%) ※ 유관기관: 지역아동센터, 드림스타트, 교육지원청, 재활센터 등 ※ 임상범위기준: 사전검사 총합 130점 이상, 준임상범위 기준: 사전검사 총합 110점~129점
---------------	---

(3) 참여자 모집 방안

구분	북구	동구
대상자모집	· 재활·동행 지원이 필요하다고 보이는 아동(지역아동센터 및 유관기관) · 재활·동행 지원이 필요하다고 보이는 아동(복지관 사례관리사업팀 내 위기아동 등) · 외부기관을 통해 재활비 지원이 가능하나 동행자 연계가 필요한 아동	· 재활·동행 지원이 필요한 아동 70%, 동행연계만 필요한 아동 30%
회의 및 선정	· 사전검사(K-CBCL, TRF) 토대로 대상자 선정	

2) 사업내용 및 사업 집행 전략

(1) 세부 사업 내용

사업명	사업내용	횟수 / 시기
‘ايا’ 만나기	사업안내 - 대상 : 지역아동센터, 지역사회 유관기관 - 내용 : 사업안내 및 대상자 추천 요청 - 방법 : 1) 네트워크를 통한 사업안내 2) 사업관련 홍보자료 발송(기관방문 및 메일 발송 등) 3) 홍보자료 및 물품 비치(재활센터 위주)	상시/ 2025년 6월 ~ 2026년 3월
	사전검사 (K-CBCL, TRF 검사) - 대상 : 지역아동센터 및 유관기관으로부터 추천받은 아동 70명 - 내용 : 추천받은 아동을 대상으로 K-CBCL, TRF 검사를 진행 ※ 보호자 및 대리양육자 각각 진행 - 방법 : 1) K-CBCL, TRF 검사 진행 2) 검사결과에 따라 대상자 50명 선정 3) 심라정서 위기 아동 추가 발생 시 스크리닝 검사 진행	1회/ 2025년 6월 ~ 2026년 3월
	종합심리검사 (full-battery 검사) - 대상 : 임상범위에 해당하는 아동 중 고위험에 해당하는 아동 12명 - 장소 : 전문병원 및 재활센터 - 내용 : 사전검사(K-CBCL, TRF)를 통해 선정된 아동에 대한 종합심리검사(full-battery 검사) 진행	1회/ 2025년 6월 ~ 2025년 12월

‘동행자’ 만나기	동행자 연계	- 대상 : 심리·정서적으로 취약한 아동 50명 - 내용 : 보호자가 동행할 수 없는 경우 동행자 매칭 - 방법 : 1) 대상자 선별 및 상담 2) 아동 - 동행자 매칭 3) 전문병원 및 재활센터 동행 ※ 동행자의 역할 - 대상아동의 전문병원 및 재활센터 동행 - 아동에 대한 관찰 및 내용전달 - 아동에 대한 정서적지지 등 ※ 동행자 자격 및 구체적인 역할 <별첨 1> 참고 → 동행 중 안전수칙 동행자 사전고지 → 보호자 서비스동의서 내 차량이용 동의 내용 포함 ※ 동행 안전관리 계획 <별첨 2> 참고	상시/ 2025년 6월 ~ 2026년 5월
	동행자 간담회	- 대상 : 동행자 4명 - 내용 : 동행자 간담회 실시(연 2회) - 사업 관련 전달사항 및 논의사항 확인 - 동행자 간담회를 통해 아동의 변화 및 특이사항 공유	2회/ 2025년 9월, 2026년 1월
	동행자 교육	- 대상 : 동행자 4명 - 내용 : 동행자 교육실시(연 5회) 1) 동행자의 역할 및 윤리 교육, 의사소통 기술 교육 등 2) 동행자의 역량을 강화할 수 있는 주제로 대면 교육을 통해 실시	5회/ 2025년 9월 ~ 2026년 1월
	맞춤재활 연계	- 대상 : 심리·정서적으로 취약한 아동 50명 - 내용 : 개입계획에 기반한 맞춤형 재활센터(놀이, 미술, 상담 등) 매칭 및 비용 지원	1회/ 2025년 6월 ~ 2026년 5월
	사후검사 (K-CBCL, TRF 검사)	- 대상 : 재활·동행 지원 대상 35명 - 내용 : 대상아동 사후검사(K-CBCL, TRF) 진행	1회/ 2025년 11월 ~ 2026년 5월

‘주변’ 만나기	보호자 참여	- 대상 : 대상자로 선정된 아동의 보호자 - 내용 : 아동 재활 진행상황에 대해 보호자와 공유 - 방법 1) 재활센터 유선상담을 통해 아동 재활 진행상황 확인(월 1회) 2) 재활센터를 통한 보호자 상담 지원(대면상담)	상시/ 2025년 6월 ~ 2026년 5월
	유관기관 참여	- 대상 : 지역아동센터, 지역사회 유관기관 - 내용 : 공동사례관리 수행 및 지속적인 상호 간 피드백 공유 - 방법 : 1) 개입상황/방향 공유(서면, 네트워크 등) 2) 아동의 심리정서적 상황 확인 및 재활 진행 상황 피드백 3) 간담회(지역별 1회, 총 2회) / 성과공유회 4) 아동 특이사항 및 추가적 개입이 필요할 경우 사례회의의 진행 및 내·외부 자원 연계	상시/ 2025년 6월 ~ 2025년 5월 3회/ 2025년 12월, 2026년 5월
	전문기관 슈퍼비전	- 대상 : 아동전문기관 혹은 지역대학 - 내용 : 사업운영 및 동행자에 대한 슈퍼비전	1회/ 2025년 12월

(2) 사업 진행 일정

주요내용		기간	2025년						2026년				
			6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
'아이' 만나기	사업안내	→											
	사전검사	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	종합심리검사	→	→	→	→	→	→	→					
'동행자' 만나기	동행자 연계	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	동행자 간담회				→				→				
	동행자 교육				→	→	→	→	→				
	맞춤재활 연계	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	사후검사						→	→	→	→	→	→	→
'주변' 만나기	보호자 참여	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	유관기관 참여	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	전문기관 슈퍼비전							→					

3) 기관 연계협력 전략

협력기관명	세부 사업명	협력 계획	비고
지역아동센터 연합회	사업안내	- 사업협조를 위한 사전 사업 홍보 및 안내 - 보호자 참여 유도를 위한 상담 진행 - 심리·정서 지원이 필요한 대상자 발굴 및 추천 - 아동에 대한 사전·사후 검사(K-CBCL, TRF) 협조	컨소시엄 기관
	유관기관 네트워크	- 아동에 대한 상호 간 피드백 공유 - 아동 재활 상황 및 재활센터 피드백 보호자 공유 - 보호자 사업 만족도 조사 진행 협조	
지역사회 유관기관	사업안내	- 심리·정서 지원이 필요한 대상자 추천	
	유관기관 네트워크	- 아동에 대한 상호 간 피드백 공유	
전문병원	종합심리검사 (full-battery 검사)	- 사전검사를 통해 선정된 아동에 대한 종합심리검사 (full-battery 검사) 진행	
재활센터	사업안내	- 심리·정서 지원이 필요한 대상자 추천	
	종합심리검사 (full-battery 검사)	- 사전검사를 통해 선정된 아동에 대한 종합심리검사 (full-battery 검사) 진행	
	유관기관 네트워크	- 재활개입 계획 수립, 아동 개입방안에 대한 피드백 - 참여아동에 대한 정확한 이해와 지도방법 안내	
	보호자 참여	- 참여아동에 대한 정확한 이해와 지도방법 안내	
아동 분야 전문기관 및 지역대학	사업운영	- 전문가 슈퍼비전	

4) 컨소시엄 참여기관 역할

구분	기관명	주요역할
사업총괄 (사업신청기관)	사회복지관	- 사업총괄 및 예산집행 - 아동 재활 연계 및 네트워크 진행 - 동행자 관리 및 배치 - 동행자 전문성 강화를 위한 교육진행 - 동행자 시스템 활용 관련 사업 구축 및 확장 역할
공동수행기관	센터협의회	- 사업협조를 위한 사전 사업 홍보 및 안내 - 보호자 참여 유도를 위한 상담 진행 - 심리·정서 지원이 필요한 대상자 발굴 및 추천 - 아동에 대한 사전·사후 검사(K-CBCL, TRF) 협조
	센터협의회	- 아동에 대한 상호 간 피드백 공유 - 아동 재활 상황 및 재활센터 피드백 보호자 공유 - 보호자 사업 만족도 조사 진행 협조

3. 예산편성

(단위 : 원)

목	세목	세세목	계	산출근거	예산조달 계획				
					신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계			101,200,000	-	100,000,000	100	1,200,000	100	자체 예산
사업비	'아이' 만나기	사업안내	2,000,000	홍보비 2,000,000×1식	2,000,000	2	-	-	-
		사전검사 (K-CBCL, TRF 검사)	300,000	K-CBCL 사전검사 비용 3,000×50명×2건	300,000	0.3	-	-	-
		종합심리검사	2,760,000	종합심리검사비 200,000×12명 ※ 검사비 평균 종합심리검사 활동비 30,000×12회	2,760,000	2.7	-	-	-
	'동행자' 만나기	동행자 활동비	34,150,000	활동비 1순위:30,000×30회×20명 2순위:30,000×15회×15명 3순위:30,000×15회×15명 교육 와:11,000×25시간×4명 추가활동비 30,000×15회×3명 활동취소비 10,000×20회	34,150,000	34.2	-	-	-
		동행자 간담회	180,000	식비 15,000×8명×1회 다과비 7,500×8명×1회	180,000	0.2	-	-	-
		동행자 교육	1,000,000	교육비 50,000×4명×5회	1,000,000	1	-	-	-
		맞춤재활	47,025,000	재활비 1순위:55,000×30회×20명 3순위:55,000×15회×15명 추가재활비 55,000×15회×2명 ※ 이동별 회기는 조정될 수 있음. ※ 자세한 내역 <별첨3>참고	47,025,000	47	-	-	-
		사후검사 (K-CBCL, TRF 검사)	210,000	K-CBCL 사후검사 비용 3,000×35명×2건	210,000	0.2	-	-	-
		'주변' 만나기	보호자 참여	1,100,000	보호자상담 55,000×20회	1,100,000	1.1	-	-
	유관기관 참여		1,350,000	간담회 225,000×2회 성과공유회 900,000×1회 (식비, 다과비, 행사 준비비)	1,350,000	1.4	-	-	-
	슈퍼비전		100,000	자문비 100,000×1회	100,000	0.1	-	-	-
	소 계			90,175,000	-	90,175,000	90.2	-	-
관리 운영비	관리·운영	차량비	9,600,000	차량렌트 400,000×12개월×2대	9,600,000	9.6	-	-	-
		출장여비	1,200,000	출장여비 50,000×12개월×2명	-	-	1,200,000	100	자체예산
		기타용품	225,000	사무용품 및 다과 등 225,000×1식	225,000	0.2	-	-	-
	소 계			11,025,000	-	9,825,000	9.8	1,200,000	100

4. 목표 및 평가

1) 산출목표

세부 사업명	산출목표	모니터링 방법
‘아이’ 만나기	1) 사업안내 및 홍보 2회 2) 사전검사 건수 50명 3) 종합심리검사 진행 12명	1) 홍보관련 사업철 2) 사전검사 결과지 3) 전문검사결과지
‘동행자’ 만나기	1) 재활개입 계획수립 35명 2) 동행자 연계 50건 3) 사후검사 건수 35명 4) 동행자 간담회 2회 5) 동행자 교육 5회	1) 재활개입 계획서 2) 아동관찰일지 3) 사후검사 결과지 4) 동행자 간담회 계획/결과보고 5) 동행자 교육 계획/결과보고
‘주변’ 만나기	1) 보호자 참여 실시 12회 / 20건 2) 네트워크 진행 상호 간의 피드백 50건 3) 유관기관 간담회 및 성과공유회 3회 4) 외부전문가를 통한 슈퍼비전 1회	1) 아동 치료일지/희망아름/ 보호자 상담 계획/결과보고 2) 희망아름 3) 유관기관 간담회 계획/결과보고 4) 슈퍼비전 계획/결과보고

2) 성과목표 및 평가 방법

성과목표	평가 도구 및 방법	측정 시기
지역 내 심리·정서 위기아동 발굴	- 성과지표 : 지역 내 심리·정서 위기아동 발굴 - 평가도구 : K-CBCL, TRF - 평가방법 : K-CBCL, TRF 검사를 통해 고위험 아동 건수 확인	사업 시행 후
참여아동의 심리·정서의 긍정적 변화 및 문제행동의 감소	- 평가도구 : 1) K-CBCL, TRF 2) 재활전문가 평가서 3) 동행자 아동관찰일지 또는 평가자료 4) 보호자·대리양육자를 통한 아동 변화 확인 - 평가방법 : 평가도구를 활용한 참여아동의 심리·정서적 상황의 전·후 비교	사업 시작, 종료 시
보호자 부재 아동에 대한 동행 연계 만족도 증가	- 성과지표 : 동행 연계 횟수 및 연계 만족도 - 평가방법 : 1) 실제 동행 연계 횟수 결과 2) 동행자, 보호자, 대리양육자 FGI	사업 시행 후
참여아동 보호자의 긍정적 양육태도 변화	- 평가도구 : 만족도 조사 - 평가방법 : 1) 만족도 조사 결과를 활용한 평가 2) 보호자, 대리양육자 FGI	사업 시작, 종료 시

<별첨 1> 동행자 자격 및 역할

동행자 자격	근무내용: 심리·정서적 상담이 필요한 아동 재활센터 동행 및 멘토 1) 2종보통 이상의 차량 실 운전 가능자(필수) 2) 사회복지사 2급 자격증 이상 소지자 및 상담 관련 자격증 소지자 우대 3) 아동 및 청소년 관련 자격증 소지자 우대 4) 복지관 근무 경력자 우대 ※ 아이의 정서적지지 부분이 중요한만큼 이동양육 경험 유무, 전체적인 성향 등의 부분을 고려예정
-------------------	---

구분	주요업무	업무내용	빈도
1	재활센터 동행	· 참여아동의 재활센터 동행 업무 · 동행과정에서의 참여아동에 대한 정서적지지 · 동행과정에서 아동 특이사항(이상징후 등) 확인 ※ <별첨 2> 활용, 동행자 활동 매뉴얼 제공 예정 발견 시 즉각 담당자에게 전달	상시
2	아동 상황 공유	· 재활센터를 통해 전달받은 피드백을 해당 기관 (복지관 및 참여기관)에 전달	상시
3	관찰일지 작성 및 개별파일 정비	· 아동 재활 상황 및 동행 중 특이점에 대해 작성 · 아동별 개별파일 정비 및 관리	상시
4	가정통신문 및 동행자 평가서 작성	· 아동 재활 진행상황에 대한 가정통신문 작성 (재활 내용, 재활 진행상황, 재활센터 피드백 등) · 참여아동에 대한 동행자 평가서 작성	월 1회
5	간담회 및 성과공유회 참석	· 간담회 진행 시 아동에 대한 정보 및 변화 정도 공유/논의	연 3회
6	교육 진행	· 동행자의 역할 및 윤리, 의사소통 기술 교육 등 동행 역할을 위한 역량강화 도모	연 5회

<별첨 2> 동행 안전관리 계획

I. 목 적

- 가. 취약계층 아동 심리지원 동행자 연계사업 활동 중 발생하는 사고로부터 동행자 및 아동을 보호함으로써 참여아동과 보호자 모두가 안심할 수 있는 안전관리 체계를 조성한다.
- 나. 사업에 참여하는 동행자를 대상으로 사업 활동에 대한 안전교육을 강화함으로써 안전사고를 미연에 방지한다.

II. 방 침

- 가. 교육을 통해 동행자가 안전수칙을 명확하게 숙지하여 아동이 안전한 환경에서 활동할 수 있도록 한다.
- 나. 동행자에게 안전관리 교육을 실시함으로써 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응하도록 한다.
- 다. 지역아동센터 및 재활센터를 포함한 인근 지역사회 유관기관과 연계 체제를 구축한다.
- 라. 참여아동, 보호자와 비상 연락망을 구축하여 긴급 상황 발생 시 신속하게 응대한다.

III. 세부 추진 계획

가. 사전 안전관리 계획

관리내용
안전관리 연간계획 수립
보험가입 여부 확인 및 추가 가입 ※ 참여아동: 영업배상책임보험 가입
안전관리 인적 조직 구성
비상연락망 구축

나. 차량 운행 시 안전관리 계획

구 분	방 안
차량 운행 전	• 차량 탑승 전, 차량 외부의 이상 유무를 확인한다. • 차량 시동 후 엔진 및 각종계기판 이상 유무를 확인한다. • 차량 출발 전 아동의 안전벨트 및 문단속을 확인한다. • 차량 엔진 및 차체의 잡음은 없는지 확인한다.
차량 운행 중	• 창문 밖으로 머리, 손을 내미는 아동에게 주의시킨다. • 안전운행을 위하여 교통안전규칙을 철저히 지킨다. • 정차는 후방의 차량에 최대한 방해되지 않는 곳에 한다. • 운행 중에는 스마트폰, 이어폰 등을 사용하지 않는다.
차량 운행 후	• 차량 타이어 압력 및 트랙은 양호한가 확인한다. • 주차 브레이크는 정상인가 확인한다. • 차량 내 아동이 두고 내린 물건은 없는지 최종 확인한다.

다. 상황별 안전관리 계획

구 분	방 안
귀가 시	• 귀가 시 여러 가지 상황에 대비하여 주변 유관기관과의 협조 체계를 구축한다. • 동행자는 내리기 전 교통상황(지나가는 오토바이 등)을 확인한다. • 동행자가 하차하여 직접 아동의 교통안전 사전지도를 실시한다. • 동행자가 아동의 집 인근까지 아동의 귀가를 도운다.
실내 환경	• 심리상담센터에 안전장치가 잘 되어 있는지 확인하는 등 안전사고를 예방한다. • 사고를 대비하여 심리상담센터에 구급상자 비치 여부를 확인하여 안전사고 발생 시 즉시 대처하고, 인근 병원 사용 사전 협조 체계를 구축한다. • 아동이 심리상담센터에서 이탈하지 않는지 센터 담당자와 지속적으로 소통한다.
이동 환경	• 차량 내 구급상자 및 소화기를 비치하여 안전사고 발생 시 즉시 대처하고, 인근 병원 사용 사전 협조 체계를 구축한다. • 귀가 안전 지도 내용을 명확하게 숙지하여 사고를 사전에 예방하고, 안전사고 발생 시 즉시 대처할 수 있도록 한다.

라. 시기별 안전관리 점검 계획

관리내용	점검시기
안전교육 실시(동행자)	연 1회
구급상자 및 소화기 점검	반기별 1회
차량 정기점검	월 1회

마. 사고 대비 및 대처

1) 안전 사고 대비 방법

- 아동의 특이체질이나 질병 유.무를 파악하여 안전관리를 해야 하며 적절한 대처를 한다.
- 응급상황 발생 시 피해를 최소화하기 위해서 응급처리 절차 과정 계획을 수립한다.
<참고1: 응급상황 처리절차>
- 아동비상연락망을 수시로 수정하여 활용한다.

2) 사고 보고 절차

- 사고 이후 처리 절차에 따라 진행한다. (사고 보고서 작성)<참고2: 사고보고서>
- 안전사고가 발생하면 피해 아동의 입장에서 우선 대처함을 원칙으로 한다.
- 아동 안전사고 발생 시 즉시 담당자에게 보고한다.
- 사고 다툼의 경우를 대비하여 발생부터 종결까지의 경과를 기록한다.

IV. 기대 효과

가. 안전한 활동 여건을 조성한다.

나. 동행자와 아동 및 관련 보호자 간에 분쟁사안을 사전에 예방하고, 경제적 손실을 미연에 방지한다.

<참고1: 응급상황 처리절차>

응급상황 처리절차

구분	응급증상 및 이에 준하는 증상일 경우	위급하지 않으나 병원 이송 경우
절차 및 이송	• 119에 연락, 신속히 이송함을 원칙으로 한다. • 응급처치자의 응급처치 후 동행자가 병·의원으로 이송한다. • 119·1339응급의료정보센터 등 구급 차량 및 요원을 기다려야 할 시에는 다음 요령에 의한다. • 동행자(이송 시 동승) • 담당자는 아동 보호자에게 상태를 알리고 이송병원, 건강보험증 지참을 안내한다.	• 동행자(응급처치 후 담당자에게 통보) • 담당자(아동 보호자에게 연락하여 적절한 병원으로 이송토록 안내, 인계하며 의료기관 선택은 보호자 의사에 따른다.) • 보호자에게 연락이 되지 않거나 올 수 없을 경우 동행자가 이송한 후 담당자에게 이를 알린다.
이송 차량	• 119 또는 병원응급차량 • 동행자 차량	
기 타	• 응급을 요하는 경우 119에 연락하여 종합병원으로 이송한다. • 응급환자 이송 및 진료 기록은 이송 즉시 기록한다. (사건의 날짜, 시간, 장소, 사고 현황, 환자상태, 응급처치내용 등을 6하 원칙에 의해 구체적으로 기록)	

<참고2: 사고보고서 양식>

사고보고서

사 고 보 고 서					
지역아동센터 명			전화번호		
지역아동센터 주소					
상해 아동 명		성별	남 여	생년월일	년 월 일
사고일자	년 월 일			사고시간	am/pm
목격자명		보호자에게 연락한 사항			
연락시간	am/pm	119신고여부		☐ 안함 ☐ 신고함 (am/pm)	
사고발생 장소	☐ 차량 내 ☐ 상담실 ☐ 화장실 ☐ 계단 ☐ 기타 ()				
사고 당시 활동 내용	☐ 상담 ☐ 이동 ☐ 계단 오르내리기 ☐ 기타 ()				
상해를 입힌 시설 설비	☐ 오르기 시설 ☐ 담/문 ☐ 장애설비 ☐ 교구 및 놀잇감 ☐ 담/문 ☐ 실외 고정물 ☐ 기타 ()				
상해의 유형	☐ 화상 ☐ 쇼크/질식 ☐ 베임 ☐ 추락/강타 ☐ 찢어짐 ☐ 물체에 끼임 ☐ 뱀 ☐ 압박, 눌림 ☐ 중독 ☐ 찰과상(벗겨짐) ☐ 뼈가 부러지거나 탈구 ☐ 호흡곤란 ☐ 기타 ()				

<별첨 3> 연차별 동행자 활동비 및 재활비

구분	기준		활동비	재활비
2 차 년 도 (50)	1순위	임상범위에 속하며, 동 행지원이 필요한 아 동(40%, 20명): 30회기	·30,000원x30회기x20명 =18,000,000	·55,000원x30회x20명 =33,000,000
	2순위	동행지원이 필요한 아 동(30%, 15명): 15회기	·30,000원x15회기x15명 =6,750,000	-
	3순위	준임상범위에 속하며 동행지원이 필요한 아 동(30%, 15명): 15회기	·30,000원x15회기x15명 =6,750,000	·55,000원x15회x15명 =12,375,000
	-		·교육 외 11,000원x25시간x4명 =1,100,000 ·추가활동비 30,000원x15회x3명 =1,350,000 ·활동취소비 10,000원x20회 =200,000	·추가재활비 55,000원x15회x2명 =1,650,000
합계			34,150,000	47,025,000
3 차 년 도 (60)	1순위	동행지원이 필요한 아 동(54%, 35명): 15회기	·30,000원x15회기x35명 =15,700,000	-
	2순위	임상범위에 속하며, 동 행지원이 필요한 아 동(15%, 10명): 30회기	·30,000원x30회기x10명 =18,000,000	·55,000원x30회x10명 =33,000,000
	3순위	준임상범위에 속하며 동행지원이 필요한 아 동(31%, 20명): 15회기	·30,000원x15회기x20명 =6,750,000	·50,000원x15회x20명 =12,375,000
	-		·교육 외 11,000원x25시간x6명 =1,650,000 ·추가활동비 30,000원x15회x5명 =2,250,000 ·활동취소비 10,000원x30회 =300,000	·추가재활비 55,000원x15회x3명 =2,475,000
합계			37,950,000	35,475,000

* 3차년도(60명)

(단위 : 원)

목	세목	세세목	계	산출근거	예산조달 계획					
					신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원	
총 계			101,800,000	-	100,000,000	100	1,800,000	100	자체 예산	
사업비	'아이' 만나기	사업안내	700,000	홍보비 700,000×1식	700,000	0.7	-	-	-	
		사전검사 (K-CBCL, TRF 검사)	270,000	K-CBCL 사전검사 비용 3,000×45명×2건	270,000	0.3	-	-	-	
		종합심리검사	2,300,000	종합심리검사비 200,000×10명 ※ 검사비 평균 종합심리검사 활동비 30,000×10회	2,300,000	2.3	-	-	-	
	'동행자' 만나기	동행자 활동비	37,950,000	활동비 1순위:30,000×15회×35명 2순위:30,000×30회×10명 3순위:30,000×15회×20명 교육 외:11,000×25시간×6명 추가활동비 30,000×15회×5명 활동취소비 10,000×30회	37,950,000	38	-	-	-	
		동행자 간담회	225,000	식비 15,000×10명×1회 다과비 7,500×10명×1회	225,000	0.3	-	-	-	
		동행자 교육	1,800,000	교육비 50,000×6명×6회	1,800,000	2	-	-	-	
		맞춤재활	35,475,000	재활비 2순위:55,000×30회×10명 3순위:55,000×15회×20명 추가재활비 55,000×15회×3명 ※ 아동별 회기는 조정될 수 있음. ※ 자세한 내역 <별첨3>참고	35,475,000	35	-	-	-	
		시후검사 (K-CBCL, TRF 검사)	180,000	K-CBCL 사후검사 비용 3,000×30명×2건	180,000	0.2	-	-	-	
		'주변' 만나기	보호자 참여	2,850,000	보호자상담 55,000×30회 보호자양육교육 200,000×6회	2,850,000	2.9	-	-	-
			대리양육자 참여	1,100,000	대리양육자상담 55,000×20회	1,100,000	1.1	-	-	-
	유관기관 참여		2,150,000	간담회 225,000×4회 성과공유회 1,250,000×1회 (식비, 다과비, 행사 준비비)	2,150,000	2.2	-	-	-	
	슈퍼비전		300,000	자문비 100,000×3회	300,000	0.3	-	-	-	
	소 계		85,300,000	-	85,300,000	85.3	-	-	-	
관리 운영비	관리·운영	차량비	14,400,000	차량렌트 400,000×12개월×3대	14,400,000	14.4	-	-	-	
		출장여비	1,800,000	출장여비 50,000×12개월×3명	-	-	1,800,000	100	자체예산	
		기타용품	300,000	사무용품 및 다과 등 300,000×1식	300,000	0.3	-	-	-	
	소 계		16,500,000	-	14,700,000	14.7	1,800,000	100	-	